

STRATÉGIE ARGUMENTAIRE

Pour le passage des ambulanciers hospitaliers en catégorie B

Note d'appui à la contre-proposition CGT / SUD du 7 juin 2026 — CHU de Toulouse

I. Constat : un décrochage devenu intenable

Trois constats se cumulent et fondent la légitimité de la revendication catégorielle :

- Une grille salariale aujourd'hui sous le SMIC pour les premiers échelons, alors que le métier suppose un diplôme d'État de niveau 4 et des responsabilités cliniques engageant directement la sécurité du patient.
- Une profession laissée pour compte lors du Ségur de la santé de 2020 : les aides-soignants et auxiliaires de puériculture — diplôme de même niveau, formation de durée comparable — sont passés de la catégorie C à la catégorie B au 1er octobre 2021. Les ambulanciers hospitaliers, eux, ont seulement été rattachés à la filière soignante par le décret n° 2022-1658, sans changement de catégorie : une reconnaissance d'appellation, pas de statut.
- Un référentiel de formation (DEA, arrêté du 11 avril 2022) qui ne couvre plus la réalité du métier exercé au quotidien au CHU de Toulouse : transports sous contrainte psychiatrique, transports pénitentiaires (UHSI), soins palliatifs, médecine nucléaire, transports mortuaires nocturnes, participation aux Plans Blancs. Ces missions exposent les agents à des risques (agressivité, charge psychologique, exposition radiologique, sécurité routière en urgence) pour lesquels ils ne sont pas formés à due proportion — et pour lesquels ils ne sont pas reconnus statutairement.

C'est l'articulation de ces trois constats — sous-rémunération, exclusion du précédent Ségur, écart missions/formation — qui doit structurer l'argumentaire, et non chacun isolément.

II. Quatre axes argumentaires

Axe 1 — L'élargissement de fait des missions, au-delà du référentiel DEA 2022

Le référentiel de formation du DEA (5 blocs de compétences, arrêté du 11 avril 2022 modifié en 2024) couvre la prise en soin générale du patient, le recueil de données cliniques, le transport et l'entretien du véhicule. Il ne couvre pas, ou de façon allusive seulement :

- la gestion de la contrainte et de l'agressivité (transports psychiatriques sous contrainte, transports pénitentiaires sous escorte) ;
- la médecine de catastrophe et les Plans Blancs, pourtant exigés en tant que de besoin pour pallier les déficits d'effectifs SAMU ;
- l'accompagnement spécifique des soins palliatifs et de la médecine nucléaire (radioprotection, accompagnement de fin de vie) ;
- la gestion relationnelle des situations de transport mortuaire face à des familles en détresse ;
- la maintenance de premier niveau du matériel, évoquée dans la fiche de poste proposée par la Direction sans qu'aucune formation n'y prépare.

Argument-clé : un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel de formation initiale engage sa responsabilité personnelle sans filet de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent, pas seulement de revalorisation — donc difficilement contournable par la Direction.

Axe 2 — Le précédent du Ségur : même niveau de diplôme, statut différencié

L'argument comparatif avec les aides-soignants doit être présenté de façon factuelle et chiffrée, sans déclaration de principe :

- DEAS et DEA : diplômes d'État, tous deux enregistrés au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, formations d'environ 800 heures.
- Les deux référentiels ont connu un élargissement comparable de leurs actes autorisés entre 2021 et 2024 (gestes d'urgence pour les ambulanciers ; actes techniques élargis — glycémie capillaire, SpO2, soins de stomie — pour les AS).
- Les AS sont passés en catégorie B par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, au titre des accords du Ségur de la santé. Les ambulanciers n'ont bénéficié d'aucune mesure catégorielle équivalente : le décret n° 2022-1658 (26 décembre 2022) les a rattachés à la filière soignante, mais maintenus en catégorie C.

Argument-clé : il ne s'agit pas de revendiquer un privilège, mais de corriger une iniquité de traitement entre deux corps de diplôme et de niveau de risque comparables, l'un revalorisé en 2021, l'autre non.

Axe 3 — Un déficit de formation qui constitue, en creux, l'argument le plus solide

Paradoxalement, le point faible apparent (absence de formation aux missions réellement exercées) est l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter pour une Direction :

- Soit la Direction reconnaît que ces missions relèvent bien d'un champ de compétences soignant élargi — ce qui justifie alors la révision du référentiel ET la révision catégorielle qui doit l'accompagner ;
- Soit elle nie cet élargissement de fait — mais alors elle doit retirer ces missions de la fiche de poste, ce que les organisations syndicales ne souhaitent pas (cf. contre-proposition, maintien des transports UHSL, psychiatrie, soins palliatifs).

Cette alternative place la Direction devant un choix binaire : reconnaître et former (donc revaloriser), ou retirer les missions. C'est le levier de négociation le plus efficace, car il ne repose pas sur une demande abstraite de justice catégorielle mais sur une cohérence interne que la Direction ne peut pas éluder sans fragiliser sa propre fiche de poste.

Axe 4 — Le décrochage salarial, lu comme un signal d'alerte RH et non comme une simple revendication

La grille indiciaire actuelle des ambulanciers (catégorie C2/C3) place certains échelons de début de carrière sous le SMIC, ce qui :

- crée une difficulté de recrutement et de fidélisation objectivement mesurable (turnover, postes non pourvus) ;
- expose l'établissement à un risque de contentieux ou de minima de tension sociale récurrente — le mouvement de grève en cours en étant la démonstration ;
- contredit le discours institutionnel sur la reconnaissance du caractère soignant du métier (décret n° 2022-1658) : on ne peut affirmer reconnaître une filière soignante tout en maintenant sa grille en catégorie C sous le seuil du SMIC.

Argument-clé : présenter le passage en catégorie B non comme une charge supplémentaire mais comme un investissement en stabilité RH, comparé au coût des grèves, du recours à l'intérim ou aux heures supplémentaires non anticipées.

III. Proposition opérationnelle : un bloc de compétences complémentaire au DEA

Pour transformer l'argument « missions hors référentiel » en levier négociable et conforme aux logiques d'ingénierie de formation existantes (DEA, FAE SMUR), nous proposons la création d'un bloc de compétences complémentaire, sur le modèle de la FAE SMUR existante (arrêté du 17 mai 2023), qui pourrait s'intituler :

« Module Missions Hospitalières Spécifiques » (MHS) — bloc complémentaire au Diplôme d'État d'Ambulancier

Module	Contenu visé	Justification (lien avec les missions exercées)
M1 — Transport sous contrainte et gestion de l'agressivité	Cadre légal de la contrainte (HSC, HDT), techniques de désescalade verbale, conduite à tenir en cas d'agressivité, protocoles d'alerte ; gestion de l'agressivité du patient détenu.	3 751 transports psychiatriques sous contrainte en 2025 ; transports UHSI maintenus sous condition de formation.
M2 — Sécurité des transports sécurisés et pénitentiaires	Conduite en situation d'urgence sous escorte, conduite à tenir en cas d'attaque/panne/accident, protocoles IRIS et escorte Police Nationale, coordination avec l'administration pénitentiaire.	Modèle CHU de Lyon cité en référence par les organisations syndicales ; condition explicite au maintien de la mission UHSI.
M3 — Accompagnement en soins palliatifs et médecine nucléaire	Notions de radioprotection et de précautions associées, accompagnement relationnel de la fin de vie et de l'entourage, communication avec les équipes soignantes spécialisées.	Missions explicitement visées par la contre-proposition syndicale comme « régulières » et non ponctuelles.
M4 — Transports mortuaires et gestion des situations conflictuelles	Cadre réglementaire du transport de corps, posture relationnelle face aux familles endeuillées, protocole de sécurité pour les interventions seul, en dehors des heures ouvrables.	Risque identifié par les organisations syndicales : aucun agent ne devrait intervenir seul sans procédure définie.
M5 — Médecine de catastrophe et Plan Blanc	Organisation de la chaîne médicale des secours, gestes d'urgence renforcés, équivalence partielle avec le tronc commun de la FAE SMUR, pour permettre une mobilisation en cas de déficit d'effectifs SAMU.	Équité revendiquée avec les ambulanciers SAMU pour l'intégration aux Plans Blancs.
M6 — Maintenance de premier niveau du matériel	Contrôles et gestes de dépannage simples (uniquement ceux pour lesquels une dotation outillage est fournie), procédure de signalement pour le reste.	Condition explicite des organisations syndicales avant toute inscription de cette tâche en fiche de poste.

Intérêt stratégique de cette proposition : elle reprend le format déjà validé et reconnu réglementairement de la FAE (formation d'adaptation à l'emploi), ce qui la rend immédiatement crédible auprès d'une Direction et d'une ARS — tout en démontrant, par construction, que les missions réellement exercées dépassent le périmètre du DEA socle. Ce constat objectif d'un écart de

formation devient alors le support documentaire de la demande de révision catégorielle, à porter ensuite au niveau ministériel (DGOS) via les fédérations syndicales nationales, le seul niveau habilité à modifier le classement statutaire d'un corps de la FPH.

IV. Plan d'action et séquençage de la négociation

Échéance	Action	Objectif
Court terme (protocole de fin de conflit)	Obtenir dans le protocole : reconnaissance écrite de l'écart missions/référentiel, engagement à créer le module MHS, NBI/IFR ou équivalent en mesure transitoire, désignation d'un cadre de santé référent.	Sécuriser des gains immédiats sans attendre l'issue (longue) d'une révision statutaire nationale.
3-6 mois	Construire, avec la Direction des Soins et la Direction Formation, le contenu détaillé du module MHS ; documenter et chiffrer l'écart (heures de formation manquantes, nombre d'agents concernés, sinistralité/incidents).	Disposer d'un dossier technique solide, co-construit, qui ne pourra pas être balayé comme une simple revendication catégorielle.
6-12 mois	Porter le dossier via les fédérations CGT/SUD Santé Sociaux au niveau national, en lien avec d'autres CHU mobilisés (Angers, Tours, Lyon) pour mutualiser un dossier inter-établissements.	Peser sur la DGOS pour une révision du statut particulier du corps des ambulanciers de la FPH (décret n° 2022-1658), sur le modèle du décret n° 2021-1257 pour les AS.
Au-delà	Mobiliser le rapport de force inter-CHU lors des prochaines négociations salariales de la FPH (clause de revoyure, conférence sociale).	Inscrire la revendication dans un calendrier national, seul niveau pertinent pour un changement de catégorie statutaire.

V. Argumentaire chiffré (données CHU de Toulouse, activité 2025)

Indicateur	Volume 2025	Portée argumentaire
Total des transports patients	56 843	Démontre le caractère structurel, non marginal, de l'activité
Transports psychiatriques sous contrainte	3 751	Réfute le terme « ponctuel » utilisé dans le projet de fiche de poste
Transports urgences	4 033	Justifie le besoin de formation aux gestes d'urgence renforcés

Ces chiffres, déjà mobilisés dans la contre-proposition syndicale du 7 juin 2026, doivent être complétés — pour renforcer le dossier catégoriel — par : le nombre de transports UHSL, de transports mortuaires

nocturnes, de missions soins palliatifs/médecine nucléaire, et si possible un indicateur de sinistralité (incidents, agressions, accidents) sur ces missions spécifiques.

VI. Anticiper les objections de la Direction

Objection probable	Réponse à apporter
« Le statut a déjà été revu en 2022 (décret n° 2022-1658) »	Ce décret a changé le rattachement de filière (technique → soignante) mais pas la catégorie (toujours C). C'est précisément l'incohérence dénoncée : reconnaissance de l'appellation sans reconnaissance statutaire.
« Le passage en catégorie B relève du niveau national (DGOS), pas de l'établissement »	Exact — c'est pourquoi la stratégie distingue les leviers locaux immédiats (protocole de fin de conflit, NBI/IFR, module MHS) des leviers nationaux à porter via les fédérations. Le CHU peut néanmoins s'engager formellement à soutenir la demande auprès de la DGOS et des autres CHU comparables.
« Créer un module de formation a un coût et un délai d'ingénierie pédagogique »	Le format proposé reprend celui, déjà validé, de la FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023) : pas de création ex nihilo, mais une déclinaison d'un dispositif existant et reconnu par les CESU.
« Les autres CHU n'ont pas ce statut non plus »	C'est un argument pour une mobilisation inter-établissements (Angers, Tours, Lyon déjà cités) plutôt qu'un argument contre la légitimité de la demande — la comparaison doit jouer en faveur d'une dynamique collective, pas être utilisée comme fin de non-recevoir.

VII. Synthèse en une phrase

Le passage en catégorie B ne doit pas être présenté comme une revendication salariale isolée, mais comme la conséquence logique et déjà actée par les pouvoirs publics pour un corps comparable (les AS), rendue d'autant plus nécessaire que les missions réellement exercées par les ambulanciers du CHU de Toulouse dépassent désormais le périmètre couvert par leur diplôme d'État — écart que le module de formation complémentaire proposé ici a précisément pour fonction de documenter et de corriger.